

Lauro R. Queiroz

NOME		NS	
IDADE: 49	PESO: 113	ALTURA: 174	PROFISSÃO: marceneiro
SINTOMAS: sonolência / cansaço / mau humor / mmII edema			
QUEIXAS: Dor cervical / Dor cabeça / esquecido			
MEDICAMENTOS: Drox 150mg / sem ação sufoco.			
Cansaço no globo ocular / faz hipoglicemia			
EXERCÍCIO FÍSICO: não consegue			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S			
HORA QUE DORME: 22		HORA QUE ACORDA: 6h	
COCHILLO (S) SIM () NÃO		DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO (S) EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () NÃO (X) NA SEMANA () NÃO raramente			
FUMO () SIM () NÃO (X) MAÇO/DIA NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO: 3x a 4x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: sim	MALLAMPATI: IV + H	IAH: 90,6	SPO2:
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA nega maxilar (S)			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: similitude fez 2 exames			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (X) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA			
(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS Hipotireoidismo			
26/05 Sente dificuldade para dormir, há muitos anos, com dificuldade em concentrar, aprender.			
31/05 P = 7.7 — P _{95%} = 11.8 cmH ₂ O (da pressão)			
23 m. de uso: 4h35'			
IAH = 20.6			
Fuga = 53.1 l/min.			
Relata melhora do cansaço e sonolência diurna. fue			
14/06 P = 10.4 cmH ₂ O Perc. 11.5 cmH ₂ O			
23 Fuga 26.9			
IAH = 36.1 elev			
m. de uso: 3h13' fue			
Troco pelo Bipap pois relata desconforto durante o sono, sufocamento.			
20/06 P = 13.3 — 11.6 cmH ₂ O Bipap			
23 IAH = 48 elev (48.0 elev) cl gas fuga			
m. de uso: 4:45 fue			
Fuga = 80.4 l/min.			
22/06 P = 13.3 — 11.6 cmH ₂ O			
23 IAH = 51.			
m. de uso: 3:35' fue			
fuga = 43.8 l/min			

28/07 P = 14 x 8 cmH₂O Bem adapt.
 23 IAH = 0.0 elev
 m. de uso: 5hr
 Yuwell ST
 NÃO DÁO IAH fue

04/08
23

19x16 cm H₂O → relata cansaço e fadiga
ST

09/08
23

mudei P1

P = 18x12

IAH no modo ST não aparece. — fua
Biologix IDO 100 — SpO₂ 72% < 90%.

12/09
23

P = 18x12

m. de uso: 6h

troquei o BIPAP q
Avaps. fua.

06
11
23

P = 15x9 cm H₂O

m. de uso: 4h45'

Fuga = 94.1

↓ 4kg de massa
corpo
— teco fixado.
fua.

07/11
23

P = 16x10 (EPAP = 8.0 cm H₂O).

m. de uso:

IAH = 46.4

ajusto a pressão, pois ele relata
falta de ar. fua

14/11
23

P = 15x9 cm H₂O

IAH = 52.9 e/h

m. de uso: 6h10'

fua cláudio

04/01
24

P = 14x8 cm H₂O

IAH = 46.4 e/h

m. de uso: 5h20'

fuga = 53.1

fua

03/02
24

P = 15x10 cm H₂O

IAH = 23.4 (IA = 15.9 / IH = 7.5)

Fuga = 94.4 l/min.

m. de uso = 5h53'

fua.

4/03
24

P = 15x10 cm H₂O

IAH = 21.8

Fuga = 62.1 med / perc. 95.3%

Relata estar bem.

fua.

10/07
24

P = 14x10 cm H₂O

IAH = 23.4 e/h

m. de uso: 6h.

fua

02/03

P = 16x9

IAH = 32, muito resfreado

fua

24/09/24 IPAP = 14 cmH₂O
EPAP = 10 cmH₂O
IAH = 17,5 e/lv
m. de uso: 5h53'
fuga: 85,1 l/m

Troco fixador
Relata sonolência

Passou pelo médico e foi detectado, polí-
temio veru e uma neoplasia mielóide
liferativa (↑↑ prod. glob. vermelhos, podem
afetar a prod. globulos brancos e plaque-
tas)

17/12
24 P = 15 x 10 cmH₂O
IAH = 17,6 e/lv
m. de uso: 5h22'
Relata melhorou a fadiga

30d T 23 ↑ 4m
5 ↓ 4h.

30/01
25 P = 15 x 10 cmH₂O
IAH = 17,2 e/lv
m. de uso: 4h52'
fuga: 62,3 lpm.

↑↑ Hemácias
3 sangrias — Ana

(97 Kg)

~~02/07/25~~ 02/05 P = 14 x 8
IAH = 46,4
m. de uso = 5h20'
fuga = 53.

- eletroencefalografia
Tumido corpo (E)
P = 97 Kg.
fuga

03/07/25 Melhora da dor cervical, dor de
cabeça; sonolência (0-10) 5 sonolência;
edema não tem mais; melhora da mi-
chia.

TROCO O DIPAP

P = 14 x 8.

fuga.

Modo (S) / IPAP = 15 / EPAP = 10 / T_{imax} 2,6 s
T_{i min} 1,5 s / Temp. sub 650ms / Acionam med /
Transição méd / marc. Facial / EPAP inicial 10.
Unid 5

RELATÓRIO DE FISIOTERAPIA

São José dos Campos, 09 de outubro de 2024.

O Sr Flávio R Queiroz, 50 anos, peso 113 kg; Altura 1.74 mts, profissão marceneiro.

HD.: AOS, Hipotireoidismo, Asma, Sinusite, Má formação congênita maxilar direito (com 2 cirurgias com enxerto para reconstituição).

Relata que durante o sono apresenta sensação de sufocamento, acorda muitas vezes durante a noite, sendo de 3 a 4 vezes para ir ao banheiro, devido noctúria, durante o dia tem sonolência excessiva chegando a dormir no volante no semáforo. Relata ainda que sente com frequência cefaleia, dor no globo ocular e mau humor. Não realiza atividade física regularmente, pois sente dor nas pernas (MMII edemaciados, com alteração da coloração) e sente indisposição.

Relata respirar pela boca durante o dia, e durante o teste com máscara nasal ele não conseguiu mantê-la fechada e relatava sufocamento.

Exame de Polissonografia:

Latência para o sono diminuída (3,5 min);

FC em REM entre 45- 113 bpm, e em NREM de 35 á 250 bpm;

IAH DE 90,6 eventos por hora, e SPO2 nadir 30%;

Despertares foi de 59,3 por hora.

Em 26-05-23, iniciamos o teste com cpap em modo automático com pressão média de 11,8 cmH2O, media de uso de 4 horas e 35min, fuga de ar de 53l/min, utilizando máscara oronasal.

Em anexo está o relatório onde a pressão chegava ao percentil de 11,8 cmH2O, e o IAH de 20,6 eventos por hora, fuga de 94.5 lpm;

Manteve-se no CPAP mas o IAH aumentou muito e chegou a 36,1 eventos por hora, com média de utilização de 3 horas e 13 min, fuga menor que a anterior, 26,9 lpm. Relata desconforto e sonolência diurna, novamente.

Conduza 30 dias, troco por um BIPAP com frequência de backup, porém sem alterações no relatório do bipap mas ele relata melhora considerável na qualidade do sono e sonolência diurna.

Porém, após dois meses relatou novamente os sintomas de sonolência excessiva e sufocamento, coloquei um bipap com avaps, porém, sem grandes alterações quando ele começa a fazer exercício físico houve melhora dos sintomas e da qualidade do sono. O que chama a atenção é que o IAH tem se mantido entre 17,5 a 23,4 eventos por hora.

Em anexo segue os relatórios do Biologix que houve uma melhora, mas ainda se mantém com uma oxigenação baixa, onde o Nadir se mantém entre 78% a 89% SpO2 o que melhorou bastante em relação a Polissonografia. O fator de modificação é a perda de peso e o exercício físico.

Isso fica claro no mês 11/23 onde ele conseguiu perder 4 kg.

Em anexo segue os relatórios do cpap e da oximetria noturna.


Fico à disposição
Ft. Ana Claudia Matos e Faria
Crefito 29544-f

Nome: FLAVIO RENATO DE QUEIROZ

Data de Nascimento: 20-5-1974

IMC: 35,27

Sexo: Masculino

Data do exame: 12-03-2023

Peso: 108 kg

Altura: 1,75 m

Médico: DRA. ANDRESSA PANSARDIS

FRANCA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 12-03-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 486,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 3,5 e 89,0 minutos. O tempo total de sono foi de 422,0 min, eficiência de 86,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,7%; estágio N2: 70,1%; estágio N3: 5,5%; sono REM: 22,7%. O índice de despertares foi de 59,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 90,6/hora, sendo 134 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 96 hipopnéias. A SpO2 média foi de 81% e a mínima de 30%, permanecendo 88,6% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 45 - 113 bpm e NREM de 35 - 250 bpm.

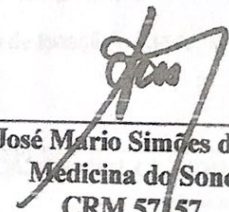
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (22), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 90,6/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=30%);
5. latência para o sono REM diminuída;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157